FOIE · FO-03

Lésion focale · foie sain

EASL 2016 · ACR AC
hémangiome, HNF, adénome, kyste, métastase

Contexte : foie sans hépatopathie chronique ni cancer connu (sinon LI-RADS ou bilan d'extension). Lésion > 1 cm indéterminée en échographie ou au scanner monophasique : **IRM avec et sans injection** en 1re intention (ou CEUS, ou scanner multiphasique). Biopsie rarement indiquée d'emblée.

SÉMIOLOGIE DES LÉSIONS FRÉQUENTES

LÉSION	T2 · DIFFUSION	DYNAMIQUE (EXTRACELLULAIRE)	PHASE HÉPATOBILIAIRE	CEUS	CONDUITE
Kyste biliaire	T2 très intense (liquide), ADC élevé	Aucun rehaussement	Hypo	Vide	Aucune
Hémangiome	T2 très intense (« ampoule »), ADC élevé	Rehaussement **nodulaire périphérique discontinu**, remplissage centripète, suit le pool sanguin ; petits : flash-filling	Hypo (pseudo-wash-out au gadoxétate)	Globules périphériques, remplissage	Aucune si typique
HNF	Iso à discrètement hyper T2 ; cicatrice T2 hyper	APHE homogène intense, iso au temps portal ; cicatrice centrale rehaussée tardivement	**Iso ou hyper** (souvent en anneau)	Remplissage centrifuge « en roue », artère nourricière	Aucune si typique (EASL)
Adénome	Variable selon le sous-type	APHE ; wash-out possible	**Hypo** le plus souvent	APHE centripète	Voir ci-dessous
Métastase	T2 modéré, diffusion restreinte, aspect en cible	Rehaussement périphérique (hypovasculaire) ou APHE (hypervasculaire), lavage	Hypo	Wash-out **précoce et marqué**	Bilan, biopsie si besoin

ADÉNOME HÉPATOCELLULAIRE · SOUS-TYPES EN IRM

HNF1A (stéatosique)
Chute de signal diffuse en opposition de phase ; rehaussement modéré ; hypo en phase hépatobiliaire

Inflammatoire
T2 intense, surtout en périphérie (**signe de l'atoll**) ; APHE persistant au temps tardif

β-caténine activée
Pas de sémiologie spécifique, parfois iso ou hyper en phase hépatobiliaire ; **risque de transformation maligne**

Femme, adénome ≥ 5 cm
résection discutée si persistant après 6 mois d'arrêt de la contraception et perte de poids

Homme ou β-caténine
résection quelle que soit la taille

< 5 cm
IRM de contrôle à 6 mois puis annuelle ; risque hémorragique si ≥ 5 cm

ARGUMENTS CLÉS · LECTURE RAPIDE

En faveur de la bénignité

- T2 très intense homogène (kyste, hémangiome)
- Rehaussement qui suit le pool sanguin
- Iso- ou hypersignal en phase hépatobiliaire (HNF)
- Graisse microscopique homogène chez une femme jeune (adénome HNF1A)
- Stabilité ≥ 2 ans

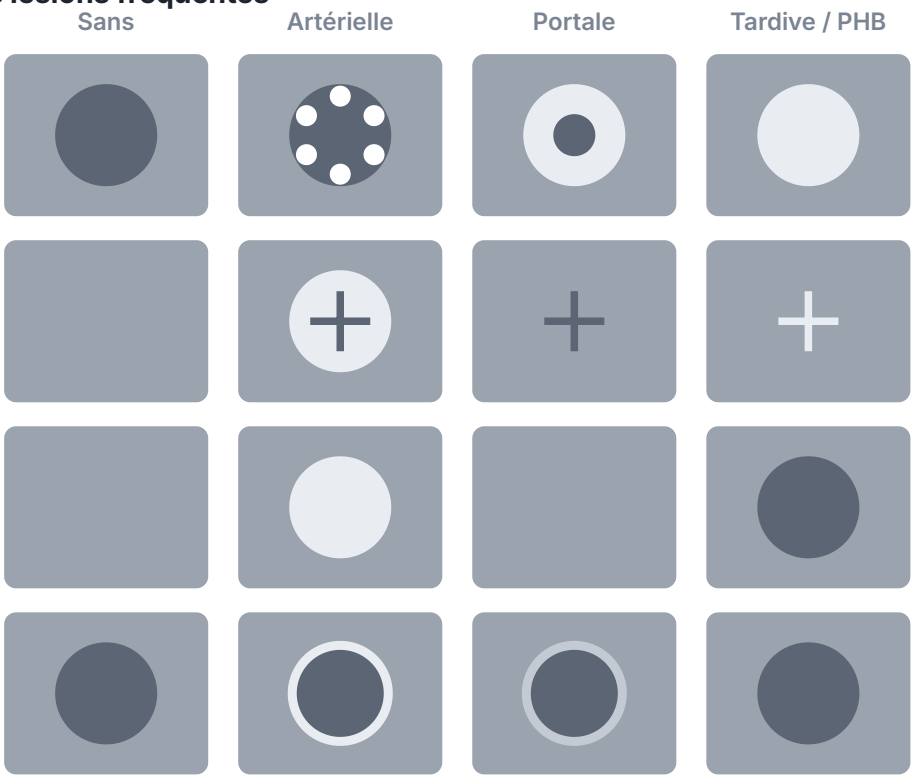
En faveur de la malignité

- Diffusion restreinte, aspect en cible
- Wash-out précoce et marqué en CEUS
- Lésions multiples de taille variable, contexte de cancer
- Rétraction capsulaire, dilatation des voies biliaires en amont
- Hépatopathie chronique sous-jacente : appliquer LI-RADS

Lésion focale · foie sain (suite)

ATLAS VISUEL

Dynamique de rehaussement des lésions fréquentes



Hémangiome
nodulaire périphérique → centripète

HNF
homogène, cicatrice tardive

Adénome
APHE, hypo en PHB

Métastase hypovasculaire
anneau périphérique

Schémas simplifiés, non à l'échelle · PHB = phase hépatobiliaire (gadoxétate)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Hémangiome hépatique
Radiopaedia · formes typiques et atypiques
radiopaedia.org/articles/hepatic-haemangioma-3

Hyperplasie nodulaire focale
Radiopaedia · cicatrice, phase hépatobiliaire
radiopaedia.org/articles/focal-nodular-hyperplas

HNF (cas)
Radiopaedia · cas multiphasique
radiopaedia.org/cases/focal-nodular-hyperplasia-

Adénome hépatocellulaire
Radiopaedia · sous-types
radiopaedia.org/articles/hepatic-adenoma?lang=us

Signe de l'atoll (adénome inflammatoire)
Radiopaedia · IRM T2
radiopaedia.org/articles/atoll-sign-liver-mri-2

Sources : EASL CPG benign liver tumours (J Hepatol 2016) – easl.eu/wp-content/uploads/2016/10/EASL-CPG-on-Management-of... · ACR Appropriateness – Liver lesion initial characterization – acsearch.acr.org/docs/69472/Narrative